

Mastitis y abscesos mamarios

1. Introducción y relevancia clínica

La **mastitis** es una **inflamación del tejido mamario**, generalmente asociada a **infección bacteriana** en el contexto de **lactancia (mastitis puerperal)**.

Es una patología **muy frecuente en el puerperio temprano** (2–10% de las madres lactantes) y una causa importante de **abandono precoz de la lactancia**, por el dolor, fiebre y malestar que produce.

El **absceso mamario** es la **complicación supurativa de una mastitis no tratada o mal manejada**, caracterizado por una **colección purulenta localizada**.

☐ En EUNACOM suele aparecer una mujer en puerperio de 2 semanas, con fiebre, eritema mamario y dolor, donde se pregunta:

- ¿Cuál es el microorganismo más probable?
 - ¿Cuál es la conducta antibiótica?
 - ¿Debe suspender la lactancia?
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

a.

Mastitis puerperal

Se origina por:

1. **Estasis de leche** (por vaciamiento incompleto o grietas mamarias).
2. **Ingreso bacteriano** a través del pezón lesionado.
3. **Infección local** del parénquima mamario.

b.

Agente etiológico principal

- **Staphylococcus aureus** (incluyendo cepas MRSA comunitarias).
- Menos frecuente: *Streptococcus agalactiae*, *E. coli*, *Klebsiella*.

C.

Factores predisponentes

- Grietas o fisuras en el pezón.
- Lactancia ineficaz o infrecuente.
- Congestión mamaria.
- Estrés y fatiga materna.
- Traumatismo mamario o presión excesiva.

☐ La **mastitis no infecciosa** también puede presentarse por estasis de leche sin invasión bacteriana (fase inicial reversible).

3. Clínica

a.

Síntomas locales

- Dolor, tumefacción, eritema y calor en una zona del pecho.
- Induración mal delimitada.
- Dolor que puede irradiarse a la axila o al brazo.
- Dificultad para amamantar del lado afectado.

b.

Síntomas sistémicos

- Fiebre $>38.5^{\circ}\text{C}$.

- Escalofríos, malestar general, astenia.
- En casos graves: signos de sepsis.

C.

Evolución natural

- Si no se trata, puede evolucionar en 2–5 días a **absceso mamario** (fluctuación, supuración).

4. Diagnóstico diferencial

Cuadro	Diferencia clínica / ecográfica
Congestión mamaria	Bilateral, sin fiebre ni signos infecciosos
Galactocele	Quiste lleno de leche, sin inflamación
Absceso mamario	Fluctuación, fiebre persistente, dolor intenso
Mastitis no puerperal	Periductal, en mujeres no lactantes, asociada a tabaquismo
Cáncer inflamatorio de mama	Eritema difuso, piel de naranja, sin respuesta a antibióticos

☐ Ante una “mastitis” que **no mejora en 10–14 días con antibióticos**, se debe sospechar **cáncer inflamatorio de mama**.

5. Exámenes complementarios

El diagnóstico es clínico, pero pueden requerirse estudios en casos atípicos o graves.

Examen	Utilidad
Hemograma y PCR	Control de inflamación (no siempre necesario).
Ecografía mamaria	Diferenciar mastitis vs. absceso. Detecta colección líquida.
Cultivo de leche o pus	En infecciones recurrentes, abscesos o resistencia antibiótica.
Biopsia	Solo si se sospecha neoplasia inflamatoria.

En la práctica, **la ecografía mamaria es el examen más útil** si se sospecha absceso o masa subyacente.

6. Clasificación clínica

Tipo	Características principales
Mastitis puerperal aguda	En lactancia, zona eritematosa y dolorosa, fiebre.
Mastitis no puerperal	En mujeres no lactantes, frecuentemente periductal.
Absceso mamario	Fluctuación palpable, fiebre persistente, pus.

7. Tratamiento (según guías MINSAL y OMS)

a.

Medidas generales

- No suspender la lactancia (favorece drenaje).
 - Vaciar el pecho frecuentemente (lactancia o extracción).
 - Aplicar compresas tibias antes y frías después de amamantar.
 - Hidratación y reposo.
 - Analgesia con **paracetamol o ibuprofeno**.
-

b.

Antibioticoterapia empírica

1. Mastitis no complicada (sin absceso, sin alergia)

- **Cloxacilina o dicloxacilina 500 mg VO cada 6 h por 10–14 días.**
- Alternativas:
 - **Cefalexina 500 mg VO cada 6 h.**
 - **Amoxicilina/ácido clavulánico 875/125 mg VO cada 12 h.**

2. Sospecha de MRSA o alergia a penicilinas

- **Clindamicina 300 mg VO cada 8 h.**
- **Trimetoprima-sulfametoxazol 160/800 mg VO cada 12 h (si lactante >2 meses).**

3. Mastitis grave o con signos sépticos

- **Hospitalizar** y administrar antibióticos EV (cloxacilina, cefazolina, clindamicina).

☐ La fiebre y el dolor deben mejorar en 48–72 horas; de no hacerlo, buscar **absceso**.

c.

Manejo del absceso mamario

1. **Confirmar con ecografía.**
 2. **Drenaje:**
 - Preferir **drenaje guiado por ecografía** con aguja o catéter (menos invasivo).
 - Si colección >3 cm o multiloculada → **drenaje quirúrgico.**
 3. **Antibióticos sistémicos** por 10–14 días (mismo esquema).
 4. Continuar **lactancia o extracción del lado afectado.**
 5. Control clínico y ecográfico posterior.
-

8. Mastitis no puerperal (periductal)

- Se presenta en mujeres no lactantes, a menudo fumadoras.
 - Involucra infección de los conductos galactóforos retroareolares.
 - Agente habitual: *Staphylococcus aureus*, *Bacteroides*, *Pseudomonas*.
 - Tratamiento:
 - **Antibióticos de amplio espectro** (amoxicilina/ácido clavulánico o clindamicina).
 - Suspensión del tabaco.
 - Drenaje quirúrgico si absceso.
-

9. Complicaciones

Complicación	Descripción
Absceso mamario	3–11% de las mastitis tratadas tardíamente

Fístula galactófora Fístula cutánea persistente tras drenaje

Interrupción de lactancia Por dolor o mal manejo

Recurrencia Mal drenaje, persistencia de fisuras

Cáncer inflamatorio Diagnóstico diferencial clave

10. Prevención

- Correcta técnica de lactancia (agarre y vaciamiento completo).
- Evitar intervalos prolongados entre tomas.
- Tratar precozmente grietas o fisuras del pezón.
- Ropa interior cómoda, sin presión excesiva.
- Mantener hidratación y descanso.

□ La **educación prenatal y posparto** sobre lactancia es la medida preventiva más eficaz.

11. Pronóstico

- Con tratamiento oportuno, la curación es completa en 5–10 días.
 - El absceso correctamente drenado también tiene **excelente evolución**.
 - Las recidivas deben hacer sospechar **mastitis granulomatosa crónica** o **cáncer inflamatorio**.
-

12. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. **Agente más frecuente:** *Staphylococcus aureus*.
2. **No suspender lactancia**, salvo contraindicación médica absoluta.
3. **Antibiótico de elección:** cloxacilina o cefalexina.
4. **Ecografía** si no mejora en 48–72 horas o se sospecha absceso.
5. **Drenaje guiado por ecografía** preferido sobre incisión quirúrgica.
6. En mastitis recurrente, **cultivo de leche** y descartar *S. aureus* resistente.
7. **Cáncer inflamatorio de mama** imita mastitis pero **no mejora con antibióticos**.



Errores comunes

- Suspender lactancia durante el tratamiento (retrasando drenaje natural).
- Uso de antibióticos inadecuados o tratamientos demasiado cortos.
- No sospechar absceso ante fiebre persistente.
- Drenar sin guía ecográfica o sin cobertura antibiótica.
- No descartar neoplasia en casos atípicos o recidivantes.

13. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **mastitis puerperal** es una infección mamaria frecuente en lactancia, causada por *S. aureus*.
2. El **diagnóstico es clínico**: dolor, eritema y fiebre.
3. **Continuar lactancia** y vaciar el pecho favorece la resolución.
4. **Antibiótico de elección:** cloxacilina o cefalexina por 10–14 días.

5. **Ecografía mamaria** si no mejora en 48–72 h → descartar absceso.
6. **Drenaje guiado por ecografía** + antibióticos para abscesos.
7. Mastitis que no responde → sospechar **cáncer inflamatorio**.